



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : اميره فهمي محمد مصطفى

المحافظة : الشرقيه الحي / المدينة : الزقازيق العنوان : --

رقم البطاقة : 26701261301501 رقم التليفون : 01060661061 تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 26-01-1967 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات الاروماتيز [14161] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: اميره فهمي محمد مصطفى National ID: 26701261301501	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



اميره
لهنى محمد مصطفى
٢٠ مجاورة ٢٠
العائش من رمضان - الشرقيه

٢٦٧ ٠١ ٢٦ ١٣ ١٥ ٠١

J08123346

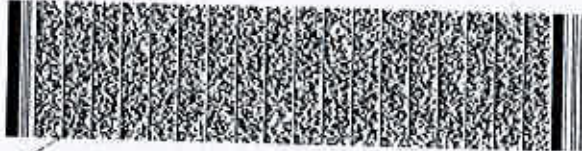
٢٠٢١/١١ ٢٦٧ ٠١ ٢٦ ١٣ ١٥ ٠١

حاصله على معتمد فنى تجارى



انثى
عماد حسين احمد الشربيني
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١١/٠٨

٨





Patient Name: Amira Fahmy Mohamed Moustafa	Date : 25/03/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 58 Year(s)
Medical ID: 272/2024	Pat. ID: 53755

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH
RESOLUTION ULTRASOUND**

Indication:

Left breast conserving therapy

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with a linear anechoic collection measuring about 43x11mm
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Right Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Summation of glandular tissue is noted in the 12O'clock position, yet on the 2D image yet on 3D and ultrasound no underlying mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Best regards,

Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
25/03/2025 12:11 PM

Patient Name : الأستاذة / اميره فهمي محمد مصطفى	Request No. : 13002972
Patient No. : 26701261301501	Request Date : 29/01/2024
Path No. : SR-134/24	Verification Date : 13/02/2024
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 57 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data : Left breast mass
Nature of specimen : Revision of slides

Gross examination:
10 blocks labelled by (806492) & (31M3150) & 15 slides were received.

Microscopic examination
* Histological type: Invasive duct carcinoma
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+2) Grade II
* DCIS: No
* Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received

IPT :
ER:strong nuclear staining in 95% of tumor cells(8/8)
PR:Moderate nuclear staining in 2% of tumor cells (4/8)
Her2: Moderate complete membrane staining in >10 of tumor cell , score(+2) .
SISH: Amplified with clusters.
KI 67: Positive nuclear staining in 15% of tumor cells

Diagnosis
Left breast mass ; slide revision :
Invasive duct carcinoma, Grade II .
IPT :
ER: Positive score(8/8)
PR:Positive score (4/8)
Her2: Equivocal score(+2) .
SISH: Amplified with clusters.
Ki67: Positive in 15% of tumor cells.

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Patient's Name: Amira Fahmy
Date: 2026-09-24
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Pelvi-abdominal ultrasonographic examination, revealed:

- The liver is not enlarged measuring about 17 cm with bright homogeneous echo-pattern. No definite focal lesions or IHRD by US criteria.
- Patent portal vein with average diameter showing normal flow direction.
- Gall bladder is averagely dilated with normal wall thickening. No stones or mud seen. Non-dilated CBD.
- Spleen is not enlarged measuring about 10 cm with homogenous echo pattern and no definite focal lesions.
- The midline structures are masked by gases.
- Colonic gaseous distension.
- Both kidneys are average in size, shape, echo-pattern and differentiation. No backpressure changes.
- No ascites at time of examination.
- No gross uterine or adnexal lesions.
- No pelvic fluid collection.

Conclusion:

- Bright (? Fatty) liver, for clinical and lab correlation.
- Otherwise, unremarkable study.

Best regards;
Dr. Mohammad Islam

Medical No. : 9389
Patient's Name: Amira Fahmy Mohammed Mustafa
Date: 2026-09-24
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast

sonography revealed:

Clinical summary: Status post left CBS followed , routine follow up study.

Findings:

Left breast:

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UOQ architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated at UOQ parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid, cystic lesions or fluid collections.

- Thickened skin and coarsen trabeculae.

- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Right breast:

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin, nipple/areola.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

- *Left breast (BIRADS 2): Post-Therapeutic sequelae.*
- *Right breast (BIRADS 1): Normal study*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan

Patient's Name: Amira Fahmy
Date: 2026-09-24
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Pelvi-abdominal ultrasonographic examination, revealed:

- The liver is not enlarged measuring about 17 cm with bright homogeneous echo-pattern. No definite focal lesions or IHRD by US criteria.
- Patent portal vein with average diameter showing normal flow direction.
- Gall bladder is averagely dilated with normal wall thickening. No stones or mud seen. Non-dilated CBD.
- Spleen is not enlarged measuring about 10 cm with homogenous echo pattern and no definite focal lesions.
- The midline structures are masked by gases.
- Colonic gaseous distension.
- Both kidneys are average in size, shape, echo-pattern and differentiation. No backpressure changes.
- No ascites at time of examination.
- No gross uterine or adnexal lesions.
- No pelvic fluid collection.

Conclusion:

- Bright (? Fatty) liver, for clinical and lab correlation.
- Otherwise, unremarkable study.

Best regards;
Dr. Mohammad Islam

Medical No. : 9389
Patient's Name: Amira Fahmy Mohammed Mustafa
Date: 2026-09-24
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast

sonography revealed:

Clinical summary: Status post left CBS followed , routine follow up study.

Findings:

Left breast:

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UOQ architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated at UOQ parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid, cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Right breast:

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin, nipple/areola.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

- *Left breast (BIRADS 2): Post-Therapeutic sequelae.*
- *Right breast (BIRADS 1): Normal study*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan